

Landing reestructurada · Método Petratti

Preparado el 22-09-2026 a partir de la sesión con el consultor de marketing (orden: problema → quién soy → método → casos → llamada a la acción) y pasado por el filtro del Módulo 3 (memoria/). Todo lo que va entre corchetes [POR ACLARAR] lo rellena la Dra. Petratti. Nada de lo que sigue promete resultados, muestra pacientes reales ni nombra medicamentos. La voz es la suya: primera persona, frases cortas, ciencia sin jerga.

1. Mapa de la página (en el orden en que se lee)

Bloque	Qué hace	Una sola frase que lo resume
0. Cabecera	Detiene el scroll con el problema, no con el servicio	"No es falta de voluntad. Es biología."
1. El problema explicado sencillo	Que lo entienda alguien de cinco años y lo firme una endocrinóloga	El cuerpo defiende su peso como un termostato
2. Quién soy	Formación, experiencia, por qué puedo decir esto	25 años de consulta, SEEDO, un libro para pacientes y otro para médicos
3. El método	Cómo funciona, qué persigue, para quién es y para quién no	Tres fases, noventa días, sin culpa
4. Lo que cambia	"Casos de éxito" que cumplen la ley: arquetipos declarados y proceso, no cifras prometidas	Lo que las personas me cuentan a los noventa días
5. Preguntas que me hacen siempre	Quita las cuatro objeciones que frenan la reserva	Precio, fármacos, online, cuánto dura
6. Llamada a la acción	Dos opciones, no más	Reserva tu valoración inicial · Descarga el capítulo 1
Pie	Lo obligatorio: colegiación, disclaimer general, vínculos, aviso legal, privacidad	

Regla de diseño: un solo botón primario visible en cada pantalla ("Reserva tu valoración inicial"); la segunda opción siempre en texto o botón secundario. Ni pop-ups, ni cuenta atrás, ni "solo quedan 3 plazas".

2. Copy, bloque a bloque

0. Cabecera

Titular (elegir uno): - A. No es falta de voluntad. Es biología. Y la biología se trata. - B. Llevas años haciéndolo todo bien. El problema nunca fue tu fuerza de voluntad. - C. Tu cuerpo no está roto. Está defendiendo un peso que no elegiste.

Subtítulo: Soy médica de familia especialista en obesidad. Llevo más de veinticinco años viendo a personas que han probado todo y se culpan por todo. Este es el tratamiento médico que les faltaba: sin dietas milagro, sin juicios y con ciencia.

Botón primario: Reserva tu valoración inicial **Enlace secundario:** ¿Todavía no? Lee gratis el capítulo 1 de *Obesidades sin culpa*

1. El problema, explicado para que lo entienda un niño de cinco años

Título: Por qué el peso vuelve (y no es culpa tuya)

Imagina que tu cuerpo tiene un termostato. No mide grados: mide cuánta energía tiene guardada. Cuando comes menos y adelgazas, el termostato cree que viene una época de hambre y hace dos cosas para protegerte: te da más hambre y gasta menos. No lo decides tú. Lo decide una parte del cerebro que no escucha razones.

Por eso pasa lo que has vivido: pierdes peso con esfuerzo y, meses después, vuelve. No fallaste tú. Falló la idea de que se puede ganar a un termostato con fuerza de voluntad.

La obesidad es una enfermedad crónica reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por las sociedades científicas europeas y españolas. Como la hipertensión o la diabetes, tiene causas biológicas, un tratamiento médico y un seguimiento. Lo que no tiene es culpa.

Tres datos que conviene saber (con su fuente en el pie de página): 1. **Se hereda más de lo que se cree.** Los estudios de gemelos y familias sitúan la heredabilidad del peso corporal entre el 40 y el 70 %. Nadie elige a sus padres. 2. **El cuerpo se resiste a perder.** Tras adelgazar, las hormonas del hambre suben y las de la saciedad bajan, y ese cambio persiste al menos un año. Además el gasto energético cae más de lo que correspondería al nuevo peso. 3. **La mayoría recupera.** Con dieta y ejercicio solos, la mayor parte de las personas recupera buena parte del peso en tres a cinco años. No por debilidad: por biología.

Cierre del bloque: Si esto te resuena, no necesitas más disciplina. Necesitas un tratamiento.

Disclaimer *referral*, en pequeño bajo el bloque: "Esta información es divulgativa. Solo una valoración individualizada puede orientar lo que es mejor para ti."

2. Quién soy

Título: Quién está al otro lado

Soy Cristina B. Petratti, médica de familia, especialista en obesidad y salud metabólica. Llevo más de veinticinco años en consulta y desde [POR ACLARAR: año] me dedico de forma preferente a la obesidad.

- **Formación:** Licenciada en Medicina [POR ACLARAR: universidad y año]. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. [POR ACLARAR: máster o formación específica en obesidad, ejercicio o nutrición, con institución y año]. En 2026 me formé en inteligencia artificial generativa aplicada a la práctica clínica y en compliance de la divulgación sanitaria digital.
- **Sociedades:** miembro de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), en su Grupo de Trabajo de Ejercicio Físico y Obesidad. Coautora de SEEDO GO!, el programa de ejercicio de la sociedad.
- **Libros:** *Obesidades sin culpa* (2026), para pacientes, y *IA en la consulta: la revolución que cabe en diez minutos* (en preparación), para médicos.
- **Dónde:** consulta en Alicante y consulta online con pacientes de toda España y de Argentina.

- **Colegiada:** nº [POR ACLARAR] del Colegio Oficial de Médicos de [POR ACLARAR].

Corrí la maratón de Londres en 2025. No lo cuento por presumir: lo cuento porque sé lo que cuesta entrenar un cuerpo que no coopera, y porque el ejercicio de fuerza es la mitad de lo que hago en consulta.

Casos de éxito en este bloque: ninguno personal. Aquí van cifras de actividad, no de resultados: "[POR ACLARAR: n] personas atendidas en el programa desde [año]", "[n] sesiones de formación a profesionales". Son verificables y no prometen nada.

3. El método

Título: Cómo trabajo: el Método Petratti

En una frase: un tratamiento médico de la obesidad en tres fases, con seguimiento cercano, ejercicio de fuerza y, cuando está indicado, tratamiento farmacológico. Sin culpa, sin dietas imposibles, sin promesas.

Cómo funciona:

Fase	Qué hacemos	Qué buscamos
1. Entender (semanas 1-2)	Historia clínica completa, analítica, composición corporal, valoración de la condición física (marcha de seis minutos, prensión manual, sentarse y levantarse), historia de intentos previos y de por qué no funcionaron.	Saber qué está pasando en <i>tu</i> biología, no en la de un libro.
2. Tratar (semanas 3-12)	Plan de alimentación realista, programa de fuerza adaptado a tu punto de partida, y tratamiento farmacológico si está indicado y lo decidimos juntas. Revisiones cada [POR ACLARAR: 2-4] semanas.	Que el termostato deje de trabajar en tu contra.
3. Mantener (a partir del mes 3)	Seguimiento espaciado, ajuste del tratamiento, prevención de la recuperación.	Que lo conseguido dure, que es lo difícil.

Qué logra el método (sin prometer): que trates la obesidad como lo que es, una enfermedad crónica; que sepas por qué fallaron los intentos anteriores; que ganes fuerza y función, no solo que pierdas peso; y que tengas una médica al otro lado durante todo el proceso. Los resultados dependen de cada persona y se revisan contigo en cada fase.

Para quién es: adultos con obesidad o sobrepeso con complicaciones que quieren un tratamiento médico serio y están dispuestos a un seguimiento de al menos tres meses.

Para quién no es: quien busca perder peso para un evento en cuatro semanas; quien necesita atención de un trastorno de la conducta alimentaria activo (te orientaré hacia quien corresponde); menores de 18 años.

Sobre la medicación: en esta página no aparecen nombres de fármacos, y no es un olvido. La ley española prohíbe la publicidad de medicamentos de prescripción al público, y yo la cumplo. Si hay un tratamiento indicado, lo hablamos en consulta, con ficha técnica delante.

4. Lo que cambia (casos de éxito que cumplen la ley)

Título: Lo que me cuentan a los noventa días

Nota para la autora: la ley española prohíbe usar testimonios de pacientes, reales o supuestos, para inducir a contratar un servicio sanitario, y prohíbe aludir a resultados garantizados. Por eso este bloque no lleva fotos de antes y después, ni kilos, ni nombres, ni vídeos de pacientes. Lleva **arquetipos compuestos declarados** (regla "una sola persona") centrados en el proceso, no en el resultado. Es más honesto y, además, es lo que convierte mejor a la persona que ya ha probado de todo.

Estas historias son arquetipos: mezclan rasgos de varias personas y ningún detalle pertenece a una sola. Ninguna cifra es una promesa.

"Pensaba que era la única a la que no le funcionaba nada." Mujer de cincuenta y pocos, cuatro dietas serias en diez años, todas con recuperación. En la primera visita entendió por qué. A los tres meses no hablaba de kilos: hablaba de que había subido las escaleras del trabajo sin parar en el rellano. Ese fue su primer dato.

"Vine por el peso y me quedé por la fuerza." Hombre de cuarenta y tantos, sedentario por trabajo, con analítica que empezaba a avisar. Empezó el programa de fuerza con dos sesiones a la semana que cabían en su agenda. A los noventa días, la analítica de control era el primer papel que pedía ver.

"Ya no me peso cada mañana." Mujer de treinta y muchos, con años de culpa y de pesarse a diario. Trabajamos el tratamiento y también la relación con la báscula. Hoy mide lo que hace, no solo lo que pesa.

Si tienes datos agregados propios (por ejemplo, porcentaje de personas que completan los noventa días, o cambio medio en la prueba de la silla), pueden ir aquí con una línea de método: "Datos de [n] personas atendidas entre [fechas], medidos en consulta; los resultados individuales varían". Sin datos medidos, no poner cifras.

5. Preguntas que me hacen siempre

- **¿Cuánto cuesta?** La valoración inicial cuesta [POR ACLARAR] €. El programa completo de noventa días tiene un precio de entre [POR ACLARAR] y [POR ACLARAR] € según el seguimiento que necesites. Lo verás antes de reservar y lo hablaremos en la valoración. Existe la opción de pago fraccionado [POR ACLARAR: condiciones].
- **¿Vas a recetarme medicación?** Solo si está indicada y lo decidimos juntas. No todo el mundo la necesita, y quien la necesita también necesita el resto del método.
- **¿Funciona online?** Sí. Atiendo por vídeo a pacientes de toda España y de Argentina. La analítica y las medidas se hacen cerca de tu casa con indicaciones mías. [POR ACLARAR: qué pruebas puede hacer online y cuáles requieren presencial.]
- **¿Cuánto dura?** El programa se diseña para noventa días. Después decidimos juntas la frecuencia del seguimiento. La obesidad es crónica; el tratamiento tiene que poder serlo.
- **¿Y si ya lo he intentado todo?** Entonces eres la persona para la que escribí esta página. Casi todo lo que has probado peleaba contra el termostato. Esto no.

6. Llamada a la acción (dos opciones, y ninguna más)

Título: Dos formas de empezar

1. **Reserva tu valoración inicial** (botón primario). Cuarenta y cinco minutos por vídeo, [POR ACLARAR] €. Salimos de la sesión sabiendo qué está pasando y si el método es para ti. Si no lo es, te lo diré.
2. **Lee gratis el capítulo 1 de *Obesidades sin culpa*** (secundario). Déjame tu correo y te lo envío. Un correo cada dos semanas, nunca más, y te das de baja con un clic.

Sin tercera opción. Ni "sígueme en Instagram", ni "escribeme por WhatsApp" en la landing: eso va en el pie.

Pie de página (obligatorio)

- Dra. Cristina B. Petratti · Médica de familia · Especialista en obesidad y salud metabólica · Colegiada nº [POR ACLARAR], Colegio Oficial de Médicos de [POR ACLARAR].
- "El contenido de esta web tiene finalidad informativa y divulgativa. No sustituye la valoración clínica individual ni constituye consejo médico personalizado." (disclaimer general del Módulo 3, literal)
- "Declaro vínculos con la industria farmacéutica: [POR ACLARAR: laboratorios y tipo de vínculo, o enlace a la página de transparencia]." (regla del efecto vigente de `M3_guia_disclosure.md`)
- Aviso legal · Política de privacidad · Política de cookies · Contacto: info@metodopetratti.com
- Referencias de los tres datos del bloque 1: [POR ACLARAR: se recomienda la Comisión de *The Lancet Diabetes & Endocrinology* sobre obesidad clínica (2025), las guías EASO 2024 y la evidencia sobre adaptación hormonal tras la pérdida de peso (Sumithran et al., *NEJM* 2011). Antes de publicar, verificar cada cita en PubMed.]

3. Página de valoración inicial (Calendly)

Estado actual de su cuenta (leído el 22-09-2026)

Ajuste	Ahora	Propuesta
Idioma de la página de reserva	Inglés (<code>locale: en</code>)	Español (es) . El perfil ya está en español; solo falta el tipo de evento.
Nombre del evento	Sesión de valoración	Valoración inicial · Método Petratti
Duración	45 min	45 min (mantener)
Enlace	<code>calendly.com/metodopetratti-info/30min</code>	<code>.../valoracion-inicial</code> (el "30min" confunde con la duración real)
Ubicación	Zoom	Zoom (mantener)
Descripción	vacía	el párrafo de abajo
Preguntas	2 (WhatsApp, profesión)	8 (abajo), con consentimiento explícito
Pago	no	[POR ACLARAR: cobrar en la reserva con Stripe o cobrar después]

Puedo aplicar estos cambios en Calendly cuando me lo confirme; hasta entonces no toco nada.

Párrafo de la página de reserva (descripción del evento)

Qué es esta sesión. Cuarenta y cinco minutos por vídeo conmigo, Cristina Petratti, médica de familia especialista en obesidad. Repasaremos tu historia (desde cuándo, qué has probado y por qué crees que no funcionó), tus analíticas recientes si las tienes y lo que buscas ahora. Saldrás sabiendo qué está pasando en tu caso y si el Método Petratti puede ayudarte. Si creo que no es lo tuyo, te lo diré y te orientaré.

Precio: [POR ACLARAR] €, [se cobra al reservar / se abona antes de la sesión]. El programa completo de noventa días cuesta entre [POR ACLARAR] y [POR ACLARAR] €; lo hablaremos en la sesión sin compromiso.

Antes de reservar, responde a unas preguntas. Me sirven para preparar tu sesión. Son datos de salud: los trato solo yo, con tu consentimiento, y puedes pedirme que los borre cuando quieras.

Preguntas cualificadoras (en el formulario de Calendly, en este orden)

#	Pregunta	Tipo	Obligatoria
1	¿Desde cuándo convives con el exceso de peso?	Opción única: menos de 2 años · 2-5 · 5-10 · más de 10 · desde la infancia	Sí
2	¿Qué has intentado hasta ahora?	Opción múltiple: dietas por mi cuenta · nutricionista · endocrino/médico · medicación · cirugía · ejercicio con entrenador · apps o programas online · otro	Sí
3	¿Por qué crees que no funcionó, o no duró?	Texto libre (2-3 líneas)	Sí
4	¿Por qué quieres agendar ahora? ¿Qué ha cambiado?	Texto libre	Sí
5	El programa completo de noventa días cuesta entre [POR ACLARAR] y [POR ACLARAR] €. ¿Encaja en lo que tienes previsto invertir?	Opción única: sí · sí, si puedo fraccionar el pago · no estoy segura/o · no	Sí
6	¿Prefieres consulta online o presencial en Alicante?	Opción única	Sí
7	Tu número de WhatsApp (solo para avisos sobre la cita)	Teléfono	Sí (ya existe)
8	He leído la política de privacidad y consiento que la Dra. Petratti trate los datos de salud de este formulario para preparar mi valoración.	Casilla, sin marcar por defecto	Sí

Se elimina "¿Cuál es tu profesión?": no ayuda a preparar la sesión y alarga el formulario. La pregunta 5 es la de "capacidad económica" del consultor, formulada sin que nadie tenga que confesar su renta: se le enseña el rango y decide.

Correos automáticos de Calendly (en español)

- **Confirmación:** "Tu valoración inicial está reservada para el {fecha} a las {hora} (hora de España). Enlace de Zoom: {enlace}. Si tienes analíticas de los últimos seis meses, tenlas a mano. Si necesitas cambiar la cita, usa el enlace de abajo. Nos vemos pronto. Dra. Cristina Petratti."

- **Recordatorio 24 h:** "Mañana a las {hora} tenemos tu valoración inicial. Busca un sitio tranquilo, con buena conexión. Si tienes báscula y cinta métrica, mejor. Dra. Cristina Petratti."
- **Zona horaria:** dejar que Calendly muestre la hora local del invitado (importante para Argentina, cinco horas menos en invierno europeo, cuatro en verano).

4. Decisiones de compliance (por qué la página es como es)

Decisión	Norma o regla	Qué se evita
Sin testimonios de pacientes, sin fotos de antes y después, sin cifras de kilos	RD 1907/1996 (publicidad de productos y servicios con finalidad sanitaria), art. 4: prohíbe testimonios de pacientes reales o supuestos como inducción al consumo y las alusiones a resultados garantizados. Código de Deontología Médica OMC 2022, capítulo de publicidad médica.	Sanción administrativa y colegial; y, sobre todo, vender una promesa.
Arquetipos compuestos y declarados	M3_regla_una_sola_persona.md (tres checks); RGPD art. 9; LOPDGDD	Identificar a una paciente en una ciudad como Alicante.
Ningún nombre comercial de medicamento; la medicación se explica por su lugar en el tratamiento	RD 1416/1994; línea roja 2 del Módulo 3	Publicidad de prescripción al público.
"Qué logra el método" en verbos de proceso, no de resultado; "los resultados dependen de cada persona"	RD 1907/1996 art. 4; Ley 34/1988 General de Publicidad y Ley 3/1991 de Competencia Desleal (publicidad engañosa)	Reclamación por publicidad engañosa.
Disclaimer general en el pie; disclaimer referral bajo el bloque del problema	M3_tres_disclaimers.md	Que la página se lea como consejo individualizado (línea roja 1).
Declaración de vínculos con la industria en el pie	M3_guia_disclosure.md (regla del efecto vigente); Código Farmaindustria	Conflicto de interés no declarado.
Número de colegiada, colegio, titulación y datos de contacto visibles	Ley 44/2003 (LOPS) art. 5; Ley 34/2002 (LSSI) art. 10	Web sanitaria sin identificación del profesional.
Formulario de Calendly con consentimiento explícito, casilla sin marcar, política de privacidad enlazada, cifrado y borrado a petición	RGPD arts. 7, 9.2.a y 13; LOPDGDD	Tratar datos de salud sin base jurídica: la infracción más cara de toda la lista.
Dos llamadas a la acción, sin urgencia artificial ("solo quedan 3 plazas")	Código de Conducta de Publicidad a través de Influencers 2025 (identificación clara); Ley 3/1991 art. 8 (prácticas agresivas)	Presión indebida en un servicio de salud.

Decisión	Norma o regla	Qué se evita
Precio y horquilla visibles antes de reservar	Ley 3/1991; buena práctica colegial de información previa	Que la primera conversación sea sobre dinero.

Cuidado con Calendly y el RGPD: el formulario de reserva envía datos de salud a los servidores de Calendly (EE. UU.). Hay que (1) firmar el contrato de encargado del tratamiento que Calendly ofrece en su panel (DPA), (2) mencionar a Calendly como encargado en la política de privacidad y (3) borrar las respuestas del panel de Calendly una vez pasadas a la historia clínica. Alternativa más limpia: preguntas 1-5 en un formulario propio en la web (con el mismo consentimiento) y Calendly solo para la hora. [POR ACLARAR: qué prefiere.]

5. Checklist antes de publicar la landing (regla del minuto del Módulo 3)

- ☐ Ningún [POR ACLARAR] a la vista.
- ☐ Ningún nombre comercial de fármaco en texto, imagen ni alt de imagen.
- ☐ Ninguna foto de paciente; las de la doctora, con derechos; las de banco, con licencia.
- ☐ Los tres arquetipos pasan los tres checks (nadie de Alicante se reconoce).
- ☐ Ninguna cifra de resultado sin dato medido y línea de método.
- ☐ Disclaimer general en pie, referral bajo el bloque 1, vínculos declarados.
- ☐ Colegiada nº y colegio visibles; aviso legal, privacidad y cookies enlazados.
- ☐ Calendly en español, descripción cargada, ocho preguntas, casilla de consentimiento sin premarcar, DPA firmado.
- ☐ Solo dos llamadas a la acción; ninguna cuenta atrás.
- ☐ Leída en el móvil de principio a fin en menos de dos minutos.

6. Lo que necesito de la autora para cerrar

1. Universidad y año de licenciatura; formación específica en obesidad; año en que la obesidad pasó a ser su dedicación principal.
2. Número de colegiada y colegio.
3. Precio de la valoración y horquilla del programa; si hay pago fraccionado y con quién.
4. Qué pruebas del método pueden hacerse online y cuáles requieren presencial.
5. Laboratorios con los que tiene vínculo vigente (para el pie) o el enlace a su página de transparencia.
6. Si quiere que aplique los cambios en Calendly (idioma, nombre, enlace, descripción, preguntas) o prefiere hacerlo ella desde el panel.
7. Datos agregados propios, si los tiene y quiere usarlos en el bloque 4.